

Số: 422/BVVPMED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc chống loạn nhịp tim BFS-ADENOSIN 3mg/ml

Để có thêm lựa chọn thuốc cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc BFS-ADENOSIN. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc

- Thành phần: thuốc có hoạt chất là adenosin 3mg, là một chất chủ vận purin.
- Cơ chế tác dụng:

Kích thích chủ yếu trên receptor P1 (trong đó bao gồm receptor adenosin A1 và A2 trên màng tế bào):

- Kích thích receptor adenosin A1 làm chậm dẫn truyền thông qua nút nhĩ thất → chống loạn nhịp tim.
 - Kích thích receptor adenosin A2 → giãn mạch vành và giãn mạch ngoại vi.
- Dạng bào chế: dung dịch tiêm trong suốt.

2. Chỉ định và liều dùng của thuốc

Chỉ định	Liều dùng và cách dùng
Điều trị loạn nhịp nhanh kịch phát trên thất (bao gồm cả hội chứng Wolff-Parkinson-White để chuyển nhanh về nhịp xoang)	Tiêm nhanh thẳng vào tĩnh mạch trong 1-2 giây hoặc vào dây truyền tĩnh mạch tại vị trí gần với bệnh nhân nhất có thể, sau đó truyền nhanh nước muối sinh lý (20ml đối với người lớn, 5ml đối với trẻ em) + NL: liều khởi đầu 6mg tiêm tĩnh mạch 1-3 giây, nếu không hiệu quả trong 1-2 phút lại tiêm tĩnh mạch nhanh 12mg và lặp lại 1 lần nếu cần. + TE: khởi đầu 0.1mg/kg (tối đa 6mg), có thể tăng lên 0.2mg/kg nếu cần đến khi nhịp nút xoang được thiết lập, cần theo dõi và ghi điện tâm đồ liên tục trong quá trình dùng thuốc.

Chẩn đoán phân biệt nhịp nhanh trên thất	Bắt đầu với liều 3mg, tiếp theo dùng liều 6mg và sau đó dùng liều 12mg sau mỗi 1-2 phút nếu cần.
Hỗ trợ trong kỹ thuật xạ hình tưới máu cơ tim	Truyền tĩnh mạch liên tục 140mcg/kg/phút trong 6 phút.

3. Các chống chỉ định của thuốc

- Mẫn cảm với adenosin;
- Người đã có từ trước hội chứng suy nút xoang hay block nhĩ thất độ hai hoặc ba mà không cấy máy tạo nhịp, do nguy cơ ngừng xoang kéo dài hoặc block nhĩ thất hoàn toàn. Người có hội chứng QT dài, hạ huyết áp nặng, suy tim mất bù.
- Bệnh hen và bệnh phế quản phổi tắc nghẽn vì có thể gây thêm co thắt phế quản.

4. Quá liều và cách xử trí

- Triệu chứng quá liều: hạ huyết áp, nhịp tim chậm hoặc hồi hộp.
- Xử trí: vì thời gian bán thải của adenosin trong máu rất ngắn nên tai biến nếu có do quá liều cũng hạn chế. Nếu tai biến kéo dài nên dùng methyxanthin như cafein hoặc theophyllin là những chất đối kháng cạnh tranh với adenosin.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HDQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

**TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH**



**PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. NGUYỄN VĂN ĐỐI**